PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DE SOUSA
7ª VARA MISTA
Rua Francisco Vieira da Costa, s/n, Raquel Gadelha, CEP 58800970
e-mail sou-vmis07@tjpb.jus.br (mailto:sza.7vara@tjpb.jus.br)**; telefone (83)35226602**

PROCESSO	0005557-40.2014.8.15.0371
	[Fornecimento de medicamentos]
AUTOR	LUIZ ARIEL GOMES DE SOUSA e outros
	Nome: LUIZ ARIEL GOMES DE SOUSA Endereço: , JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58000-000 Nome: MINISTERIO PUBLICO Endereço: , JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58000-000
RÉU	MUNICIPIO NAZAREZINHO
	Nome: MUNICIPIO NAZAREZINHO Endereço: , JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58000-000

SENTENÇA

Cuida-se de ação civil pública para a defesa de direito indisponível com pedido de antecipação de tutela e de multa cominatória ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA em face do MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO.

O parquet age na tutela dos interesses do(a) incapaz LUIZ ARIEL GOMES, 02 ANOS DE IDADE. Segundo a inicial, o tutelado necessita de um APARELHO DE JOELHO VALGO BILATERAL E UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, para tratamento do PÉ PLANO CID10 M 21.4.

Argumentou que o(s) medicamento(s)/alimento(s) possui(em) valor(es) elevado(s), o que dificulta sua aquisição pelo(a) paciente, haja vista ser hipossuficiente.

Diz, ainda, que diante da inércia do Poder Público em atender o requerimento para fornecimento do(s) medicamento(s)/alimento(s) entendeu prudente recorrer a via judicial para evitar possíveis lesões a(o) paciente, tendo em vista que a não utilização contínua da medicação/alimentação coloca em risco sua saúde e/ou vida.

Ao final, pediu a antecipação de tutela para que o réu promova a entrega dos aparelhos, de imediato, evitando-se assim o agravamento do quadro clínico do paciente, tornando inútil eventual tutela apenas em definitivo, ante o lapso temporal.

Juntou documentação.

A liminar foi deferida (id.25717476 -p. 58/61).

Citado, a parte promovida não apresentou contestação (id. 29532307).

Instado de se pronunciar, o Ministério Público inicialmente pugna pelo arquivamento, informando que não mais subsistir a necessidade dos aparelhos. No entanto, apresentou nova manifestação, pugnando pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na exordial, ante a satisfação integral do objeto, confirmando a tutela antecipada, pelo período indicado na decisão, ocasião em que requereu a desconsideração da promoção do arquivamento equivocadamente anexada nos autos conforme o expediente ID 30750097.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a Fazenda promovida foi citada e absteve-se de apresentar defesa, DECRETO-LHE A REVELIA.

Como a revelia não induz a veracidade dos fatos afirmados pelo autor quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (Novo CPC, arts. 344 e 345, II), como neste caso, aquela decretação terá o único efeito a perda da prerrogativa de intimação pessoal[1]. Nesse contexto, quando se tratar de autos físicos, a fluência do prazo iniciará da publicação no órgão oficial. No caso de processo eletrônico, entretanto, a intimação, regra geral, é realizada por meio eletrônico. Desse modo, ainda que revel a Fazenda Pública, terá ciência do ato judicial, desde que cadastrado no polo passivo da ação, o que ocorre no caso em tela.

Por outro lado, com fundamento no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido, uma vez que não se torna mais necessária a realização de nenhuma outra prova.

Inicialmente, entendo não ser o caso de arquivamento, conforme requerido pelo autor antes de se pronunciar pela última vez nos autos, uma vez que houve o cumprimento integral da obrigação, conforme ele próprio informou (id. 30884523).

Assim, não é o caso de perda superveniente do objeto da lide, devendo ser analisado o mérito da demanda.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a examinar o mérito.

Conforme relatado, cuida-se de ação civil pública envolvendo direito à saúde, em que o paciente necessita de um APARELHO DE JOELHO VALGO BILATERAL E UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, para tratamento do PÉ PLANO CID10 M 21.4, e que tal pleito foi negado pelo promovido.

O direito à saúde, que é tido como um direito fundamental, tem tratamento previsto na II Seção do Título VIII do texto constitucional, a partir do art. 196 e ss.

Apesar de o dispositivo constitucional, em seu art. 196, descrever uma norma programática de princípio institutivo, o Supremo Tribunal Federal (STF), alinhado à força normativa da Constituição, identificou, também, na cláusula um direito público subjetivo do indivíduo em face do Estado (AgR-RE 271.286-8/RS).

Em outras palavras, o supracitado dispositivo não precisa de regulamentação, podendo ser aplicado de forma imediata. Assim, considerando que o mandamento estatal não pode se converter em mera promessa, tem se admitido na jurisprudência a busca do Poder Judiciário para sanar as ineficiências ou falhas encontradas nas políticas públicas de saúde, uma vez que não há sentido em se proteger direitos fundamentais sem meios de efetivá-los. Do contrário, os direitos seriam meras declarações e não efetivo objeto de tutela jurídica.

Feita essas considerações iniciais, é importante observar que o ente público estabelece listas de medicamentos passíveis de fornecimento, tendo em vista, entre outros requisitos, a demanda da população, a eficiência e o equilíbrio financeiro. O juízo de ponderação administrativa é realizado em face da observância de outros interesses, inclusive, de um sistema de saúde sustentável.

Sobre o tema, dispõe a Lei nº 8.080/90, alterada pela Lei nº 12.401/2011:

"Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador;

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

(…)

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;

(…)

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, **com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;**

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, **com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS**, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde." *Destaquei.*

Portanto, para os pleitos de fornecimento de medicação incluída em listas de dispensação do Sistema único de Saúde (SUS), mas que não foi fornecido ao paciente, o comando judicial será simplesmente o de cumprimento de uma política pública já existente e com previsão orçamentária.

No entanto, observo que muitas vezes os medicamentos fornecidos pelo SUS à população não oferecem a eficácia desejada para o tratamento da enfermidade, logo, deve ser conservada a obrigação (solidária entre União, Estado e Município) do respectivo fornecimento, uma vez que o direito fundamental à saúde deve ser preservado.

Assim, a descentralização não serve como empecilho para que aquele que não encontrou atendimento em qualquer das esferas da federação demande a prestação de qualquer dos gestores do SUS.

Afinal, a interpretação dos arts. 23 e 196, ambos da Constituição Federal, que melhor se coaduna com os interesses da coletividade é aquela que amplia os instrumentos e meios da parte obter o

efetivo acesso ao serviço, de modo a se promover a prestação mais célere, adequada e eficiente possível.

Logo, não se exclui da apreciação do Poder Judiciário os casos de descumprimento das regras de repartição de competências entre os entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, no entanto, essa distribuição não é oponível ao usuário, devendo ser resolvida entre os próprios entes estatais.

Em relação aos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, recentemente, o STJ enfrentou a questão em julgamento paradigmático, que recebeu a seguinte ementa:

> ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
>
> TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4.**TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.** Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Assim, restou demonstrado a possibilidade de, e**m casos excepcionais e desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos supracitados**, o poder público ser compelido a fornecer medicamento não incorporado nos normativos do Sistema Único de Saúde.

Portanto, a atual configuração institucional, a via judicial se torna a regra para se obter medicamentos fora dos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), hipótese que não depende apenas da interpretação do ordenamento jurídico, mas da verificação de certos elementos concretos ligados ao quadro do paciente e ao tratamento que se espera obter, além da sua capacidade financeira para custear o medicamento.

Passo a análise dos requisitos de forma pormenorizada:

O PRIMEIRO REQUISITO consiste na comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente (seja da rede pública ou particular), da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento para tratar a enfermidade diagnosticada, devidamente acompanhado da comprovação da ineficácia, para a moléstia do paciente, dos medicamentos oferecidos pelo SUS.

É relevante para a compreensão do tema verificar que a jurisprudência é firme no sentido de privilegiar os medicamentos que já são ofertados pelo SUS. Confira-se:

> "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. PRETENSÃO MANDAMENTAL APOIADA EM LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DA PROVA SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Conquanto o receituário médico tenha sido emitido por profissional que atendeu a impetrante pelo Sistema Único de Saúde - SUS, na Policlínica Oswaldo Cruz, não há como determinar-se o fornecimento do colírio Combigan pelo Estado de Rondônia, se este medicamento não consta da listagem contida em portaria expedida pelo Ministério da Saúde **e não há comprovação de que outros medicamentos disponibilizados pelo Estado não sirvam ao tratamento do glaucôma, ou que não há fornecimento de medicamentos adequad**os. Precedentes: STJ, AgRg no RMS 34.545/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/02/2012; STF, SL 47 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-076. 2. De outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde, ainda em 2012, manifestou que o colírio pretendido poderia ser adquirido na Policlínica Oswaldo Cruz, mas não há prova nos autos de que tenha havido recusa em seu fornecimento. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no RMS 45.703/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2015). *Destaquei.*
>
> "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETE MELLITUS. PRETENSÃO MANDAMENTAL APOIADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DA PROVA SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.** 1. O recurso ordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou o mandado de segurança por meio do qual a impetrante objetiva compelir a autoridade indigitada coatora a fornecer-lhe medicamentos e insumos para o tratamento de Diabete Mellitus. 2. O Supremo Tribunal Federal, após realização de audiência pública sobre a matéria, no julgamento da SL N. 47/PE, ponderou que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades fático-probatórias, ressaltando que, 'em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente'.(...)" (STJ, RMS 30.746/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2012). *Destaquei.*

Desse modo, na análise do caso concreto, deve o magistrado considerar a sua falta de capacitação técnica para decidir sobre tratamentos de doenças e analisar os critérios de comprovação e

eficácia de medicamentos, valendo-se de apoio técnico na forma da Recomendação nº 31/2010 do CNJ, bem como de consulta aos bancos de dados criados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais, além de perícias, etc.

O SEGUNDO REQUISITO diz respeito à comprovação, no caso concreto, de que a aquisição do medicamento pelo paciente implique o comprometimento da sua subsistência e/ou do seu grupo familiar, demonstrando a incapacidade de arcar com os custos do fármaco prescrito.

Tal requisito se justifica "considerando a inexorável escassez de recursos orçamentários do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a exigência da hipossuficiência se apresenta como elemento de preservação do princípio da isonomia, já que não caberia ao SUS fornecer na via judicial medicamento a pessoa com razoável poder aquisitivo em detrimento e em prejuízo das pessoas carentes (que muitas vezes não possuem sequer condições de acessar o Judiciário)[1]".

Aqui, dois aspectos merecem ser destacados:

1º) não se trata de exigência de prova de pobreza ou miserabilidade, mas da demonstração da incapacidade financeira. Portanto, não são utilizados os parâmetros de aferição de hipossuficiência da legislação consumerista ou do art. 98 do CPC, pois, dependendo do valor do tratamento, mesmo a pessoa que tenha bons rendimentos e patrimônio razoável pode não ter condições de arcar com os custos. Adotam-se, pois, critérios como a razoabilidade e proporcionalidade.

2º) o exame da incapacidade financeira deve levar em consideração os rendimentos do grupo familiar e não apenas do paciente isoladamente. É que, no dizer do Ministro Marco Aurélio Melo, "por ser específico, o dever familiar precede o estatal, que é custeado por toda a sociedade por meio dos tributos. O Estado atua subsidiariamente – exclusiva ou complementarmente, a depender do nível de capacidade financeira da família solidária. No campo processual, para obtenção da liminar, tutela antecipada ou específica, incumbe ao requerente instruir a inicial com a declaração não só da própria incapacidade financeira, como também dos familiares acima discriminados – cônjuge, companheiro(a), ascendentes, descendentes e irmãos –, devendo qualificá-los com a indicação de nomes, registros de identidade e endereços"[2].

O TERCEIRO REQUISITO atende à imposição do art. 19-T, inciso II, da Lei nº 8.080/90, pois o medicamento pretendido deve ter sido aprovado pela ANVISA, que é o órgão de controle sanitário do país, evitando-se que o cidadão seja exposto a medicamentos experimentais sem comprovação científica acerca da eficácia, da efetividade e da segurança do medicamento.

No caso dos autos, por meio dos documentos (ID. 25717476. Pag. 15/17) afere-se que o substituído foi diagnosticado com PÉ PLANO CID 10 M 21.4 e necessita de um APARELHO DE JOELHO VALGO BILATERAL E UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, tendo sido esclarecido pelo médico assistente do paciente, Dr. Luiz Alberto de Oliveira, que a criança necessita dos aparelhos, o que justifica a imprescindibilidade do procedimento prescrito.

Quanto ao registro na ANVISA, infere-se dos documentos anexos que o medicamento vindicado neste feito se encontra devidamente registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A insuficiência econômica também restou comprovada, tendo sido anexado aos autos declaração de isenção de imposto de renda dos genitores da assistida (ID. 25717476 - Pág. 22).

Assim, verifica-se que estão presentes os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não foi indicado também por parte do Município nenhuma alternativa de tratamento substitutivo ao procedimento solicitado. Portanto, tendo em vista a delicada situação do substituído, entendo por perfeitamente cabível a pretensão requerida pelo promovente, tendo em vista a obrigação do promovido em custear o tratamento de saúde necessário e indispensável ao restabelecimento da hipossuficiente enferma.

Por outro lado, em relação às tutelas de urgência, elas podem ser deferidas no momento em que haja risco de perecimento de direito.

Nas palavras do renomado doutrinador Pontes de Miranda apud (LEME. 2012 p.12), acerca das espécies de tutela de urgência: “enquanto as cautelares garantem para satisfazer; as antecipatórias satisfazem para garantir”. Aplicando o entendimento citado a este caso específico, tem-se que a tutela antecipada assegura o procedimento cirúrgico tão logo para garantir o direito à vida/saúde do substituído que estão por perecer, caso não seja concedida a tutela antecipada.

Portanto, o presente juízo reafirma a concessão da tutela antecipada, dando importância a relevância do fundamento de urgência – perigo de dano, conforme redação do art. 300 do Novo CPC - na preservação da vida/saúde (em outras palavras, o direito material) da criança LUIZ ARIEL GOMES, sendo o medicamento comprovadamente necessário.

Corroborando igual compreensão, segue o entendimento jurisprudencial:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1 - Impõe-se a concessão de antecipação dos efeitos da tutela se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação e, ainda, vislumbrar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2 - O Estado tem o dever de assegurar a saúde do cidadão, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 196. 3 - Afigura-se razoável e proporcional a fixação de multa diária com a finalidade de garantir a eficácia da medida de urgência e evitar a desobediência daquele que é recalcitrante em não atender o comando judicial. (TJ-MS - AI: 14149283920158120000 MS 1414928-39.2015.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 08/03/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2016)

Confirma-se, para tanto, o deferimento da tutela pretendida pelo promovente.

Finalmente, deve declarar cumprida a obrigação de fazer, com suporte nos arts. 924, II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o autor menciona na sua última manifestação que houve a satisfação integral do objeto da presente ação (id. 30884523).

ANTE O EXPOSTO, resolvendo o mérito, acolho o pedido para condenar o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA para fornecer a criança** LUIZ ARIEL GOMES, os **insumos** indicados na inicial (APARELHO DE JOELHO VALGO BILATERAL E UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS), confirmando a tutela antecipada já deferida.

Declaro, por sentença, cumprida a obrigação de fazer, para que produza seus efeitos legais, o que faço com suporte nos arts. 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Fazenda Pública vencida isenta de custas, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios, por se tratar a parte autora do Ministério Público (STJ - REsp n. 1.374.541/RJ - Rel. Min. Gurgel de Faria - DJe de 16.08.2017).

Não se tratando de condenação superior aos valores indicados no § 3º do art. 496 do CPC, não se vislumbra necessária a remessa prevista no caput deste artigo. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se. Havendo apelo, proceda-se por atos ordinatórios.

Finalmente, proceda-se a alteração do polo ativo, fazendo constar o Ministério Público Estadual como autor.

Sentença publicada e registrada. Intimem-se.

Sousa-PB, data e assinatura eletrônicas.

VINICIUS SILVA COELHO

Juiz de Direito

Código de Normas da CGJPB, art. 102. Fica autorizado o uso do despacho como carta citação/ notificação/intimação/precatória/ofício pelos magistrados do primeiro grau de jurisdição, o qual consiste na prolação de ato decisório cujo teor sirva, automaticamente, de instrumento para citação, intimação, notificação, deprecação ou ofício.

1 APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. EFEITO PROCESSUAL DA REVELIA ART. 346, DO CPC DE 2015 -.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUBILAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ARTS. 204 E 205, DA LEI MUNICIPAL N° 5.819/03 -. PREENCHIMENTO DO REQUISITO. REPONSABILIDADE CIVIL ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC DE 2015. Preliminar. Não evidenciado o cerceamento de defesa alegado, haja vista a incidência dos efeitos processuais da revelia, em desfavor da Fazenda Pública, a indicar a fluência dos prazos da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme o art. 346, do CPC de 2015. Nesse sentido, ausente nulidade do feito. Mérito. I - O direito da parte autora à complementação dos proventos de aposentadoria, em razão da satisfação do requisito da jubilação através do Regime Geral de Previdência Social, na forma dos arts. 204 e 205, da Lei Municipal n° 5.819/03, antes da entrada em vigor da Lei Municipal n° 6.500/07, consoante o art. 75. Precedentes deste Órgão Fracionário. II - A responsabilidade pelos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da C. F. - pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato e o dano. Não configurado o dever de indenizar do município de Rio Grande, tendo em vista a falta de comprovação do nexo de causalidade entre as moléstias incapacitantes epicondilite crônica lateral do cotovelo direito, síndrome do túnel de carpo bilateral, e sinal de Phalen -, e o agir ilícito do município alegado, ônus da parte autora a teor do art. 373, I, do CPC de 2015. Além do mais, a declinação expressa no interesse da instrução probatória, em que pese a oportunidade processual. Preliminar rejeitada. Apelação e recurso adesivo desprovidos. Sentença mantida em remessa necessária. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078926813, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/10/2018)

Assinado eletronicamente por: VINICIUS SILVA COELHO
01/06/2020 11:17:26
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 31138656

20060111172667900000

IMPRIMIR GERAR PDF